



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN PONEK
(PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENCY KOMPREHENSIF)
24 JAM**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



LEMBAR PENGESAHAN

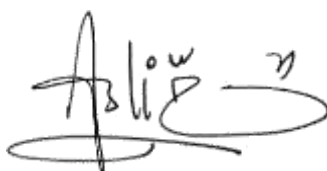
Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan PONEK
(Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) 24 Jam

Disusun oleh :
Ketua Tim PONEK RS Prima Husada Malang


dr. Aida Musyarofah, Sp. OG

Di Setujui Oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M.Kes. AFP

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestanti, M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) 24 Jam dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Pedoman Pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) 24 Jam ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2018 dan telah dilakukan revisi beberap kali termasuk di tahun 2022 dan 2025 ini. Rumah Sakit PONEK 24 Jam merupakan bagian dari sistem rujukan dalam pelayanan kedaruratan dalam maternal dan neonatal, yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi, prasarana, sarana dan manajemen yang handal.

Untuk mencapai kompetensi dalam bidang tertentu, tenaga kesehatan memerlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku dalam pelayanan kepada pasien. Panduan ini dibuat dengan harapan mampu melaksanakan kegiatan Pelayanan PONEK 24 Jam dengan tepat dan maksimal dalam pencapaian hasilnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan PONEK 24 Jam ini, sehingga mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestanti, M. Kes



TIM PENYUSUN
PEDOMAN PELAYANAN PONEK
(PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF) 24 JAM

1. dr. Resti Lestanti, M. Kes
2. dr. Aida Musyarofah, Sp. OG
3. dr. Arif Heru Wicaksono, Sp. An
4. dr. Dicky Faturrohman, Sp. A M Biomed
5. dr. Isrotul Annisa
6. dr. dr. Yolanda alifvichasari
7. Daning Pravitia Y.S, S.Tr. Keb
8. Siti Zaimah Amd. Keb
9. Bdn. Nining Tri Sari, S. Keb
10. Triasih Amd. Keb
11. Elok Oktaviana Amd. keb
12. Leny Puji rahayu Amd. Keb
13. Rismaya Felantriardianti S. Kep. Ns
14. Anita Sari S. Kep. Ns
15. Rita Purnamasari Amd. Kep.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
TIM PENYUSUN	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
BAB I 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 TUJUAN DAN FUNGSI PEDOMAN PELAYANAN PONEK 24 JAM	2
1.3 RUANG LINGKUP PELAYANAN.....	3
1.4 PENGERTIAN DAN BATASAN OPERASIONAL.....	3
BAB II	4
STANDAR KETENAGAAN	4
2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia.....	4
2.2 Distribusi Ketenagaan.....	4
2.3 Pengaturan Jaga / Dinas. Jam Dinas Tim PONEK:	5
BAB III	6
STANDAR FASILITAS.....	6
3.1 Denah Ruang.....	6
3.2 Standar Fasilitas Ponek.....	6
BAB IV KEAMPUAN PELAYANAN	14
4.1 Pengertian Pelayanan PONEK 24 Jam.....	14
4.2 Pengertian Rumah Sakit Pelayanan PONEK 24 Jam	14
4.3 Pengertian Rujukan	14
4.4 Kemampuan Pelayanan PONEK Rumah Sakit Kelas C.....	14
BAB V	18
TATA LAKSANA	18
5.1 Kriteria Pelayanan Ponek.....	18
5.2 Tata Laksana Pelayanan Kehamilan.....	18
5.3 Tatalaksana Pelayanan Persalinan	20
5.4 Tata Laksana pelayanan Nifas.....	22
5.5 Tata Laksana Rawat Gabung	23
5.6 Tata Laksana Inisiasi Menyusui Dini (IMD).....	23
5.7 Tata Laksana Pelayanan Metode Kangguru (PMK) pada Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR)	26
5.8 Tata Laksana Bayi Baru Lahir.....	27
5.9 Tata Laksana Pelayanan High Care Unit	28
5.10 Tata laksana pelayanan kesehatan neonatal	29
5.11 Tata laksana pelayanan Ginekologi	29
5.12 Tata Laksana pelayanan kamar operasi.....	29
5.13 Sistem Rujukan.....	30
5.14 Alur masuk pasien PONEK.....	31
BAB VI	32
PENERAPAN PROGRAM RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI.....	32
6.1 PENGERTIAN	32
6.2 TUJUAN	32
6.3 SASARAN	32
6.4 STRATEGI PELAKSANAAN.....	32



BAB VII.....	34
LOGISTIK.....	34
7.1 SARANA DAN PRASARANA	34
BAB VIII KESELAMATAN PASIEN.....	37
8.1 Pengertian	37
8.2 Tujuan.....	37
8.3 Standar Keselamatan Pasien.....	37
8.4 Kejadian Yang Dapat Muncul Dalam Pelayanan	37
8.5 Tata Laksana	38
BAB IX	41
KESELAMATAN KERJA	41
9.1 Latar Belakang.....	41
9.2 Pengertian	41
9.3 Tujuan.....	41
9.4 Tata Laksana Keselamatan Kerja.....	41
9.5 Prinsip Keselamatan Kerja	42
BAB X	43
PENGENDALIAN MUTU	43
BAB IX	44
PENUTUP	44
LAMPIRAN	45



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia.....	4
Tabel 2. 2 Pengaturan Jaga / Dinas. Jam Dinas Tim PONEK.....	5
Tabel 3. 1 Peralatan Maternal Esensial	10
Tabel 3. 2 Peralatan Neonatal Esensial Pada Perawatan Neonatal NICU	12
Tabel 5. 1 Pemantauan Observasi Persalinan	20
Tabel 7. 1 Sarana dan Prasarana (Logistik).....	34
Tabel 8. 1 Mutu Pelayanan PONEK.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Denah Rumah Sakit Prima Husada Malang	45
Lampiran 2 Denah PONEK RS Prima Husada.....	46



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN PONEK
(PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF) 24 JAM

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu di Rumah Sakit Prima Husada, maka perlu adanya kebijakan;
- : b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu adanya Kebijakan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) Rumah Sakit Prima Husada;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Kebijakan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 24 jam;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/Menkes/SK/VII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK) 24 JAM**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Pelayanan PONEK 24 jam adalah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif 24 Jam
- (2). Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam
- (3). Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab timbal balik dua arah dari sarana pelayanan primer kepada sarana kesehatan sekunder dan tersier.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 1

- (1). Terdapat Tim PONEK yang ditetapkan oleh Rumah Sakit dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya
- (2). Tim PONEK diketuai oleh dokter spesialis kandungan

BAB III

PELAYANAN PONEK

Pasal 1

- (1). Rumah Sakit menetapkan regulasi tentang pelaksanaan PONEK 24 jam

Pasal 2

- (1). Rumah Sakit membuat perencanaan melalui program kerja yang menjadi dalam pelaksanaan program PONEK Rumah Sakit sesuai maksud dan tujuan
- (2). Maksud dan tujuan yang dimaksud pasal (2) yaitu Rumah sakit melaksanakan program PONEK sesuai dengan pedoman PONEK yang berlaku dengan langkah langkah sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu.
 - 2) Mengembangkan kebijakan dan standar pelayanan ibu dan bayi.
 - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
 - 4) Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetric dan neonates termasuk pelayanan kegawatdaruratan (PONEK 24 jam).
 - 5) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan Pembina teknis dalam pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif serta Perawatan Metode Kanguru (PMK) pada BBLR
 - 6) Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
 - 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program RSSIB 10 langkah menyusui dan peningkatan



- 8) kesehatan ibu
- 9) Melakukan pemantauan dan analisis yang meliputi:
 - a) Angka keterlambatan operasi section caesaria
 - b) Angka kematian ibu dan bayi
 - c) Kejadian tidak dilakukannya inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi barulahir
- (3). Rumah sakit mengadakan program Pembinaan jejaring rujukan yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepada fasilitas kesehatan jejaring, berbagi pengalaman dalam pelayanan ibu dan anak serta peningkatan kompetensi jejaring rujukan secara berkala.

BAB IV JEJARING PONEK

Pasal 1

- (1). Untuk meningkatkan efektifitas sistem rujukan maka Rumah sakit melakukan pembinaan kepada jejaring fasilitas Kesehatan rujukan yang ada
- (2). Salah satu tugas dari rumah sakit dengan kemampuan PONEK adalah melakukan pembinaan kepada jejaring rujukan seperti Puskesmas, Klinik bersalin, praktek perseorangan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (3). Rumah sakit memetakan jejaring rujukan yang ada dan membuat program pembinaan jejaring setiap tahun.
- (4). Rumah sakit mengadakan program Pembinaan jejaring rujukan yang dilakukan dengan mengadakan
 - a) pelatihan kepada fasilitas kesehatan jejaring,
 - b) berbagi pengalaman dalam pelayanan ibu dan anak serta
 - c) peningkatan kompetensi jejaring rujukan secara berkala.
- (5). Rumah Sakit melakukan pembinaan terhadap jejaring secara berkala
- (6). Rumah sakit melakukan evaluasi program pembinaan jejaring rujukan

BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 1

Rumah Sakit melalui Tim PONEK menyelenggarakan pelatihan diantaranya pelatihan :

- a) Penanganan pasien kegawatdaruratan maternal neonatal
- b) Alur penerimaan pasien masuk
- c) Pembinaan jejaring rujukan dengan pelatihan kepada fasilitas kesehatan jejaring,
- d) berbagi pengalaman dalam pelayanan ibu dan anak serta
- e) peningkatan kompetensi jejaring rujukan secara berkala



Pasal 2

Setiap tenaga medis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit wajib mengikuti Pedoman Pelayanan PONEK 24 jam sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB V

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 1

- (1). Terdapat laporan tentang pelaksanaan program PONEK
- (2). Terdapat laporan tentang monitoring dan evaluasi secara rutin program PONEK
- (3). Terdapat laporan tentang pelaksanaan pembinaan jejaring secara berkala
- (4). Terdapat laporan tentang monitoring dan evaluasi program pembinaan jejaring rujukan.

Pasal 2

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang Pada
tanggal 11 September 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr.Resti Lestanti,M.Kes

LAMPIRAN**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA****NOMOR : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025****TENTANG****PEDOMAN PELAYANAN PONEK
(PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENCY KOMPREHENSIF) 24 JAM****PEDOMAN PELAYANAN PONEK (PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL
EMERGENCY KOMPREHENSIF) 24 JAM DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
MALANG****BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015. Terjadi penurunan AKI di Indonesia dari 390 pada tahun 1991 menjadi 305 pada tahun 2015.

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Angka kematian anak dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menunjukkan AKN sebesar 15 per 1.000 kelahiran hidup, AKB 24 per 1.000 kelahiran hidup, dan AKABA 32 per 1.000 kelahiran hidup.

Dalam rangka upaya percepatan penurunan AKI dan AKB maka pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS) yang diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Program EMAS berupaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal melalui : 1) meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 Rumah Sakit PONEK dan 300 Puskesmas/Balkesmas PONEK dan 2) memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar puskesmas dan rumah sakit (Kemenkes, 2017).

Rumah sakit PONEK 24 Jam merupakan bagian dari sistem rujukan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal, yang sangat berperan dalam menurunkan angka



kematian ibu dan bayi baru lahir. Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi, prasarana, sarana dan manajemen yang handal. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia perlu dilakukan pembekalan melalui standarisasi pelayanan yang ditetapkan di Rumah Sakit melalui pembuatan pedoman. Pedoman pelayanan PONEK ini merupakan pedoman untuk melaksanakan kebijakan pelayanan maternal dan perinatal di rumah sakit Prima Husada Malang yang tercakup dalam ruang lingkup dan batasan operasional.

1.2 TUJUAN DAN FUNGSI PEDOMAN PELAYANAN PONEK 24 JAM

1.1.1 Tujuan Umum

Terciptanya sistem pelayanan PONEK 24 Jam yang bermutu dan paripurna sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di rumah sakit.

1.1.2 Tujuan Khusus

- a. Menyelenggarakan Asuhan kebidanan terstandar pada pelayanan PONEK 24 jam
- b. Menyelenggarakan Asuhan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
- c. Menyelenggarakan penyuluhan dan konseling Asuhan sayang ibu dan bayi

1.1.3 Fungsi pelayanan Ponek 24 jam

1. Terbentuknya Tim PONEK Rumah Sakit
2. Tercapainya kemampuan teknis Tim PONEK sesuai standar
3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Maternal dan Perinatal yang bermutu dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia
4. Terlaksananya manajemen pelayanan maternal dan perinatal dari aspek administrasi & manajemen, kompetensi SDM, fasilitas dan sarana serta prosedur pelayanan di RS
5. Terklaksananya system rujukan pelayanan maternal dan perinatal
6. Menstandarisasi layanan kesehatan di rumah sakit yang sesuai dengan akreditasi.



1.3 RUANG LINGKUP PELAYANAN

1. Stabilisasi di UGD dan persiapan untuk pengobatan definitif.
2. Penanganan kasus gawat darurat oleh tim PONEK Rumah Sakit di ruang tindakan.
3. Penanganan operatif cepat dan tepat meliputi laparotomi, dan section caesaria.
4. Perawatan intensif ibu dan bayi.
5. Pelayanan Asuhan Ante Natal Risiko Tinggi.

1.4 PENGERTIAN DAN BATASAN OPERASIONAL

- 1 PONEK merupakan singkatan dari Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
2. Rumah Sakit PONEK 24 Jam adalah Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.
3. Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab timbal balik dua arah dari sarana pelayanan primer kepada sarana kesehatan sekunder dan tersier.
4. Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi adalah Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, umum dan khusus yang telah melaksanakan 10 Langkah menuju perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.



BAB II STANDAR KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan KEPMENKES RI No : HK.01.07/MENKES/560/2025 dan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit tahun 2012, maka standar tenaga Tim PONEK di Rumah Sakit Prima Husada Malang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Sertifikasi	Jumlah Kebutuhan
1	Ketua Tim PONEK	Dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan	S1 Kedokteran	1
2	Sekretaris	Perawat/Bidan	DIV/S1 Kebidanan	1
3	Anggota	Dokter spesialis anestesi	S1 Kedokteran	1
4		Dokter Spesialis Anak	S1 Kedokteran	1
5		Pendidikan dokter umum	S1 Kedokteran	2
6		Bidan PONEK IGD	DIII/DIV/S1 Kebidanan	1
7		Bidan Ruang bersalin & Nifas	DIII/DIV/S1 Kebidanan	2
8		Perawat ruang Neonatus	DIII/DIV/S1 Kebidanan/keperawatan	1
9		Perawat/Bidan Ruang Operasi	DIII/DIV/S1 Kebidanan	1
10		Bidan ICU	DIII/DIV/S1 Kebidanan	1
11		Bidan poli obgyn	DIII/DIV/S1 Kebidanan	1
Total				13

2.2 Distribusi Ketenagaan.

Pelayanan PONEK dipimpin oleh dokter dan staf yang terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan yang berkualitas untuk menjamin dilaksanakannya pelayanan yang telah ditentukan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketua Tim PONEK adalah dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang terlatih
2. Koordinator IGD adalah dokter umum yang bertugas di IGD
3. Bidan PONEK adalah bidan yang bertugas di IGD PONEK
4. Koordinator Poli kebidanan adalah lulusan DIII Kebidanan, masa kerja minimal 3 tahun
5. Koordinator pelayanan ruang bersalin dan nifas adalah lulusan DIII Kebidanan, masa kerja minimal 3 tahun.
6. Koordinator Pelayanan Perinatologi adalah lulusan DIII Kebidanan atau Keperawatan masa kerja 3 tahun



2.3 Pengaturan Jaga / Dinas. Jam Dinas Tim PONEK:

Tabel 2. 2 Pengaturan Jaga / Dinas. Jam Dinas Tim PONEK

No	Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu Kerja	Jumlah SDM
1	Dokter spesialis kebidanan dan kandungan	Sesuai jadwal konsulan	24 jam	2 Orang
2	Dokter spesialis anak	Sesuai jadwal konsulan	24 jam	3 orang
3	Dokter Spesialis Anestesi	Sesuai jadwal konsulan	24 jam	3 Orang
4	Dokter UMUM	3 shif	24 jam	8 Orang
5	Bidan & Perawat	3 shif	Jam 06.30-14.30	6 orang
			Jam 14.00-21.00	6 orang
			Jam 21.00-06.30	5 orang



BAB III STANDAR FASILITAS.

3.1 Denah Ruang

Ada pada lampiran

3.2 Standar Fasilitas Ponek.

Standart Fasilitas PONEK Berdasarkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan PONEK antara lain :

1. Kriteria Umum Rumah Sakit PONEK.

- a) Ada dokter jaga yang terlatih di IGD untuk mengatasi kasus emergency baik secara umum maupun emergency obstetrik neonatus.
- b) Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.
- c) Mempunyai Standar Operating Prosedur penerimaan dan penanganan pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.
- d) Pedoman tidak ada uang muka bagi pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.
- e) Mempunyai standar respon time di IGD selama 10 menit, di kamar bersalin kurang dari 30 menit, pelayanan darah kurang dari 1 jam.
- f) Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk melakukan operasi, bila ada kasus emergency obstetrik atau umum.
- g) Tersedia kamar bersalin yang mampu menyiapkan operasi dalam waktu kurang dari 30 menit.
- h) Memiliki kru/petugas yang siap melakukan operasi atau melaksanakan tugas sewaktu-waktu, meskipun *on call*.
- i) Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter/petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat.
- j) Tersedia pelayanan penunjang lain yang berperan dalam PONEK, seperti laboratorium dan radiologi selama 24 jam, recovery room 24 jam, obat dan alat penunjang yang selalu siap tersedia.
- k) Perlengkapan
 1. semua perlengkapan harus bersih (bebas, debu, kotoran, bercak, cairan dll)
 2. permukaan metal harus bebas karat atau bercak
 3. semua perlengkapan harus kokoh (tidak ada bagian yang longgar atau tidak stabil)
 4. permukaan yang dicat harus utuh dan bebas dari goresan besar
 5. roda perlengkapan (jika ada) harus lengkap dan berfungsi baik
 6. instrumen yang siap digunakan harus disterilisasi
 7. semua perlengkapan listrik harus berfungsi baik (saklar, kabel dan steker menempel kokoh)



2. Kriteria Khusus

a) Prasarana dan sarana.

Dalam rangka Program Menjaga Mutu pada penyelenggaraan PONEK diperlukan :

1. Ruang rawat inap yang leluasa dan nyaman
2. Ruang tindakan gawat darurat dengan instrumen dan bahan yang lengkap.
 - Ruang pulih/observasi pasca tindakan.
 - Protokol pelaksanaan dan uraian tugas pelayanan termasuk koordinasi internal

b) Kriteria umum ruangan :

1. Struktur Fisik

- a. Lantai dari porselin atau plastik
- b. Dinding di cat dengan bahan yang bisa dicuci

2. Kebersihan

- a. Cat dan lantai berwarna terang sehingga kotoran dapat terlihat dengan mudah.
- b. Ruang bersih dan bebas debu, kotoran, sampah atau limbah rumah sakit.

3. Pencahayaan

- a. Pencahayaan terang dari cahaya alami atau listrik.
- b. Listrik berfungsi baik, kabel dan steker tidak membahayakan dan semua lampu berfungsi baik dan kokoh.
- c. Tersedia peralatan gawat darurat.
- d. Ada cukup lampu untuk setiap neonatus

4. Ventilasi

- a. Ventilasi, termasuk jendela cukup jika dibandingkan dengan ukuran ruang.
- b. Kipas angin atau pendingin ruang harus berfungsi baik.
- c. Suhu ruangan harus dijaga 24-26°C.
- d. Pendingin ruang harus dilengkapi filter (sebaiknya anti bakteri).

5. Pencucian tangan

- a. Wastafel dilengkapi dengan sabun cair atau desinfektan
- b. Wastafel, kran dan dispenser harus dipasang pada ketinggian yang sesuai (dari lantai dan dinding).
- c. Tidak boleh ada saluran pembuangan air yang terbuka.
- d. Kriteria khusus ruangan
 1. Area cuci tangan di ruang obstetrik dan neonatus
 2. Area resusitasi dan stabilisasi di Ruang Obstetri dan Neonatus/ IGD
 - a) Kamar PONEK di unit gawat darurat terpisah dari kamar gawat darurat lain. Sifat privasi ini penting untuk kebutuhan ibu bersalin dan bayi.
 - b) Tujuan kamar ini ialah: memberikan pelayanan darurat untuk stabilisasi kondisi pasien, misalnya syok, henti jantung, hipotermi, asfiksia dan apabila perlu menolong darurat serta resusitasi dilengkapi dengan meja resusitasi bayi, dan inkubator.



c) Kamar PONEK membutuhkan :

1. Lemari dan troli darurat
2. Tempat tidur bersalin serta tiang infus.
3. Incubator transport
4. Meja, kursi
5. Aliran udara bersih dan sejuk
6. Pencahayaan
7. Lampu sorot dan lampu darurat
8. Oksigen dan tabungnya atau berasal dari sumber dinding
9. Lemari isi : perlengkapan persalinan, vakum, forceps, kuret, obat/infus
10. Alat resusitasi dewasa dan bayi
11. Wastafel dengan air mengalir dan antiseptic
12. Alat komunikasi dan telepon ke kamar bersalin
13. Nurse station dan lemari rekam medik
14. USG mobile
15. Sarana pendukung, meliputi :
toilet, tempat persiapan peralatan (linen dan instrument),
ruang sterilisator dan jalur ke ruang bersalin/kamar operasi
terletak saling berdekatan dan merupakan bagian dari unit
gawat darurat.

d) Ruang Maternal.

1. Kamar Bersalin.
 - Lokasi di lantai 4 gedung C
 - Tiap ibu bersalin harus punya privasi agar keluarga dapat hadir.
 - Ruang bersalin tidak boleh merupakan tempat lalu lalang orang
 - Kamar bersalin terletak satu area dengan kamar neonatal, untuk memudahkan transport bayi dengan komplikasi ke ruang rawat.
 - Kamar bersalin dekat dengan ruang jaga perawat (nurse station memudahkan pengawasan ketat setelah pasien partus sebelum dibawa ke ruang rawat (post partum). Selanjutnya bila diperlukan operasi, pasien akan dibawa ke kamar operasi yang berdekatan dengan kamar bersalin.
 - Ada kamar mandi-toilet berhubungan kamar bersalin
 - Tersedia Ruang post partum yang terpisah dari fasilitas : toilet, kloset, lemari.
 - ada fasilitas untuk cuci tangan
 - Ruang perawat (nurse station) berisi meja, telepon, lemari berisi perlengkapan darurat atau obat



2. Pojok Laktasi

Terdapat ruangan yang berisi Meja ganti popok, sofa, wastafel

3. Ruang Operasi

- Instalasi kamar operasi diperlukan untuk tindakan operasi seksio sesaria dan laparatomi.
 - Disediakan unit komunikasi dengan kamar bersalin. Didalam kamar operasi tersedia perlengkapan resusitasi dewasa dan bayi.
 - Kamar pulih ialah ruangan bagi pasien pasca bedah berisi: meja, kursi, perawat, lemari obat, mesin pemantau tensi/nadi oksigen, tempat rekam medic, troli darurat.
 - Pengawasan langsung dari meja perawat ke tempat pasien
 - Fasilitas pelayanan untuk unit operasi :
 1. Nurse station yang juga berfungsi sebagai tempat pengawas lalu lintas orang.
 2. Ruang kerja kotor yang terpisah dari ruang kerja bersih ruang ini berfungsi membereskan alat dan kain kotor, tempat cuci wastafel besar untuk cuci tangan dan fasilitas air panas atau dingin, ada meja kerja dan kursi, troli.
 3. Saluran pembuangan kotoran atau cairan.
 4. Ruang tunggu keluarga
 5. Kamar sterilisasi yang berhubungan dengan kamar operasi. Ada autoklaf besar berguna bila darurat.
 6. Kamar obat berisi lemari dan meja untuk distribusi obat.
 7. Ruang cuci tangan (scrub) sekurangnya untuk 2 orang terdapat di depan kamar operasi atau kamar bersalin. Wastafel itu dirancang agar tidak membuat basah lantai. Air cuci tangan haruslah steril.
 8. Ruang kerja bersih .Ruang ini berisi meja dan lemari berisi linen, baju dan perlengkapan operasi. Juga terdapat troli pembawa linen.
 9. Kamar ganti
4. Ruangan penunjang:
- a. Ruang perawat/bidan
 - b. Ruang rekam medic
 - c. Toilet staf
 - d. Ruang persiapan diperlukan bila ada kegiatan persiapan alat/bahan
 - e. Gudang peralatan
 - f. Ruang linen bersih
 - g. Laboratorium 24 jam
 - h. Radiologi dan USG

5. Peralatan Esensial



Tabel 3. 1 Peralatan Maternal Esensial

	JENIS PERALATAN	KOMPONEN	JUMLAH
1	Kotak Resusitasi	a. Ambubag dan sungkup b. Laringoskop dewasa berfungsi baik c. Laringoskop bayi d. Selang reservoir oksigen	1 1 1 1
2	Troli emergency maternal	1) Infus D5% 500 ml 2) Infus Gelafusal 500 ml 3) Infus Manitol 500 ml 4) Amiodaron inj 3 ml 5) Atropin Sulfat inj 1 ml 6) Dextrose 40% 25 ml 7) Dobutamin inj 5 ml 8) Dopamin HCL inj 5 ml 9) Ephedrine inj 1 ml 10) Epinephrin inj 1 ml 11) Lidokain 2% 2 ml 12) Norepinephrine inj 13) Valisamben inj 2 ml 14) Clopidogrel tab 75 mg 15) Nospirinal tab 80mg 16) Aminophylline inj 10 ml. 17) Dexametason inj 1 ml 18) Furosemid inj 2 ml 19) Natrium phenytoin inj 2 ml	1 1 1 4 2 1 1 1 1 5 3 1 1 5 5 1 1 2 1



3	Box emergensi infant warmer	1) Atropin Sulfat inj 1 ml	2
		2) Dextrose 40% 25 ml	1
		3) Dobutamin 5 ml	1
		4) Ephidrine inj 1 ml	5
		5) Epinephrin inj 1 ml	1
		6) Lidokain 2% 2 ml	3
		7) Norepinephrine inj 4 ml	1
		8) Phenobarbital inj 1 ml	1
		9) Diazepam rectal 5 mg	1
		10) Aminophylline inj 10 ml.	1
		11) Dexametason inj 1 ml	1
		12) Natrium phenytoin inj 2 ml	1
		13) Ett uncuffed No 2,5	1
		14) Ett uncuffed No 3,0	1
		15) Hi Oxy Mask Anak	1
		16) Handskun steril No 65	1
		17) Iv Can no 24,26	1
		18) Iv can no 26	1
		19) Perfusor White	1
		20) Sput 10 cc,5cc,3cc1 cc	2
		21) Spalk 5x10 cm	1
		22) Suction Catheter No 6	1
		23) Suction Catheter No 8	1
		24) Tree Way cateter stopcock	1
		25) Terufusion	1
		26) Tree way cateter stopcock	1
		27) Terufusion Terumo	1
		28) Infus Gelafusal	1
3	Set HPP	Asam Traneksamat Inj	2
		Misoprostol Tab	3
		Blood Set	2
		Benang Bol	1
		Foley Cateter no 18	1
		Foley Cat no 16 Hi Oxy	1
		Mask Dewasa	1
		Inf Ns 0,9%	1
		Inf RL	2
		IV Can no 18	1
		Kondom	1
		Sarung tangan obgyn steril	1
		Sput 50 cc Lubang Pinggir	1
		Water For Injektion	1



4	Set Eklamsi	Ca Glukonas Cairan MgSo4 40% Cairan MgSo4 20% Blood set Folley Cateter No : 16 Oxy Mask Dewasa Iv canul no 18 Needle no 23 RL 500 ml Oxyflo Dewasa Sputit 10 cc Sputit 20 cc Urin Bag Model T Cairan wi 25 ml Guedel airway 80mm Guedel airway 90mm Guedel airway 100mm	1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
5	Forceps naegele		1
6	Monitor denyut jantung/pernapasan (NST)		2
7	Fetal dopler		2
8	AVM (Aspirasi Vakum Manual)		1
9	Cuvis		4
10	Set Sectio Saesaria		4
11	USG Transport		1

Tabel 3. 2 Peralatan Neonatal Esensial Pada Perawatan Neonatal NICU

No.	Jenis Peralatan	Jumlah
1	Inkubator	4
2	Infant Warmer : 1 (satu) di Instalasi IGD 1 (satu) unit di Kamar Bersalin 1 (satu) di instalasi kamar operasi 1 (satu) di NICU	4



3	Pulse Oxymeter Neonatus	3
4	Terapi Sinar	1
5	Syringe Pump	5
6	Infus Pump	6
7	Tabung Oksigen	2
8	Lampu Tindakan	2
9	Alat-Alat Resusitasi Neonatus Laryngoskop Neonatal, Tong spatel Ambu Bag	1
10	CPAP (<i>Continous Positive Airways Preassure</i>)	5
11	Incubator Transport	1
12	Box bayi	15

BAB IV KEAMPUAN PELAYANAN

4.1 Pengertian Pelayanan PONEK 24 Jam

Pelayanan PONEK 24 Jam adalah pemberian pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.

4.2 Pengertian Rumah Sakit Pelayanan PONEK 24 Jam

Rumah Sakit PONEK 24 Jam adalah Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam.

Rumah Sakit PONEK 24 Jam merupakan bagian dari sistem rujukan dalam pelayanan kedaruratan dalam maternal dan neonatal, yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi, prasarana, sarana dan manajemen yang handal. Untuk mencapai kompetensi dalam bidang tertentu, tenaga kesehatan memerlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku dalam pelayanan kepada pasien.

4.3 Pengertian Rujukan

1. Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab timbal balik dua arah dari sarana pelayanan primer kepada sarana kesehatan sekunder dan tersier.
2. Sistem Rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Kegiatan rujukan mencakup:
 - a. Rujukan Pasien
Rujukan pasien internal adalah rujukan antar spesialis dalam satu rumah sakit. Rujukan eksternal adalah rujukan antar spesialis keluar rumah sakit dengan mengikuti sistem rujukan yang ada
 - b. Rujukan Manajemen
Dapat berupa permintaan kepada unit yang lebih mampu atau bantuan kepada unit yang kurang mampu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang tidak dapat diatasi sendiri.

4.4 Kemampuan Pelayanan PONEK Rumah Sakit Kelas C

1. Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Fisiologis
 - a. Pelayanan Kehamilan
 - b. Pelayanan Persalinan
 - c. Pelayanan Nifas
 - d. Asuhan Bayi Baru Lahir (Level 1)
 - e. Immunisasi dan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)
 - f. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)



-
- g. Pelayanan Rawat Gabung Ibu dan Bayi
 - h. Pemberian ASI Eksklusif
 - i. Pelayanan Metode Kangguru (PMK) pada BBLR
2. Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal dengan risiko tinggi
- 1). Masa antenatal
 - a. Perdarahan pada kehamilan muda
 - b. Nyeri perut dalam kehamilan muda dan lanjut
 - c. Gerak janin tidak dirasakan
 - d. Demam dalam kehamilan dan persalinan
 - e. Kehamilan ektopik (KE) & Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
 - f. Kehamilan dengan Nyeri kepala, gangguan penglihatan, kejang dan/koma, tekanan darah tinggi
 - 2). Masa intranatal
 - a. Persalinan dengan parut uterus
 - b. Persalinan dengan distensi uterus
 - c. Gawat janin dalam persalinan
 - d. Pelayanan terhadap syok
 - e. Ketuban pecah dini
 - f. Persalinan lama
 - g. Induksi dan akselerasi persalinan
 - h. Aspirasi vakum manual
 - i. Ekstraksi Cunam
 - j. Seksio sesarea
 - k. Epiotomi
 - l. Kraniotomi dan kraniosentesis
 - m. Malpresentasi dan malposisi
 - n. Distosia bahu
 - o. Prolapsus tali pusat
 - p. Plasenta manual
 - q. Perbaikan robekan serviks
 - r. Perbaikan robekan vagina dan perineum
 - s. Perbaikan robekan dinding uterus
 - t. Reposisi Inersio Uteri
 - u. Histerektomi
 - v. Sukar bernapas
 - w. Kompresi bimanual dan aorta
 - x. Dilatasi dan kuretase
 - y. Ligase arteri uterine
 - z. Bayi baru lahir dengan asfiksia
 - aa. BBLR
 - bb. Resusitasi bayi baru lahir
 - cc. Anestesia umum dan lokal untuk seksio sesaria
 - dd. Anestesia spinal, ketamine



- ee. Blok paraservikal
- ff. Blok pudendal (bila memerlukan pemeriksaan spesialisik, dirujuk ke RSU)
- 3). Masa Post Natal
 - a. Masa nifas
 - b. Demam pasca persalinan
 - c. Perdarahan pasca persalinan
 - d. Nyeri perut pasca persalinan
 - e. Keluarga Berencana
 - f. Asuhan bayi baru lahir sakit (level 2)
- 3. Pelayanan Kesehatan Neonatal
 - a. hiperbilirubinemi,
 - b. asfiksia,
 - c. trauma kelahiran,
 - d. hipoglikemi
 - e. kejang,
 - f. sepsis neonatal
 - g. gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit gangguan pernapasan,
 - h. kelainan jantung (payah jantung, payah jantung bawaan,PDA),
 - i. gangguan pendarahan,
 - j. renjatan (shock),
 - k. aspirasi meconium
 - l. koma,
 - m. Inisiasi dini ASI (*Breast Feeding*),
 - n. Kangaroo Mother Care,
 - o. Resusitasi Neonatus,
 - p. Penyakit Membran Hyalin,
 - q. Pemberian minum pada bayi risiko tinggi,
- 4. Pelayanan Ginekologi
 - a. Kehamilan ektopik
 - b. Perdarahan uterus disfungsi
 - c. Perdarahan menoragia
 - d. Kista ovarium akut
 - e. Radang Pelvik akut
 - f. Abses Pelvik
 - g. Infeksi Saluran Genitalia
 - h. Skreening pelayanan HIV – AIDS
 - i. Perawatan Khusus / High Care Unit
 - j. Pelayanan Penunjang Medik
 - k. Pelayanan Darah
 - l. Merencanakan kebutuhan darah di RS



-
- ~~m. Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus pada pasien sebelum melakukan transfuse darah~~
 - n. Melakukan kerjasama dengan penyedia darah atau PMI setempat
5. Perawatan Intensif
- a. Pemantauan terapi cairan
 - b. Pengawasan gawat nafas / ventilator
 - c. Perawatan sepsis
 - d. Pelayanan pengelolaan resusitasi segera untuk pasien gawat, tunjangan kardio-respirasi jangka pendek dan mempunyai peran memantau serta mencegah penyulit pada pasien medik dan bedah yang berisiko.
 - e. Ventilasi mekanik dan pemantauan kardiovaskuler sederhana.
 - f. Memiliki Dokter jaga 24 jam dengan kemampuan melakukan resusitasi jantung paru.
 - g. Dokter Spesialis Anestesi
6. Penunjang
- a. Radiologi
 - b. USG/Ibu dan Neonatal
7. Laboratorium
- a. Pemeriksaan rutin darah, urin
 - b. Kultur darah, urin, pus
 - c. Kimia



BAB V

TATA LAKSANA

5.1 Kriteria Pelayanan Ponek

- 1 Ada dokter jaga yang terlatih di IGD untuk mengatasi kasus emergensi baik secara umum maupun emergency obstetrik — neonatal.
- 2 Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.
- 3 Mempunyai Standar Operating Prosedur penerimaan dan penanganan pasien kegawat-daruratan obstetrik dan neonatal.
- 4 Mempunyai standar respon time :
 - a. IGD selama 10 menit,
 - b. kamar bersalin kurang dari 30 menit,
 - c. pelayanan darah kurang dari 60 menit
- 5 Tersedia kamar operasi siap (siaga 24 jam) untuk melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik atau umum.
- 6 Tersedia kamar bersalin yang mampu menyiapkan operasi dalam waktu kurang dari 30 menit.
- 7 Memiliki petugas yang siap melakukan operasi atau melaksanakan tugas sewaktu-waktu, meskipun *on call*.
- 8 Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter / petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat.
- 9 Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam.

Di Rumah sakit Prima Husada Malang masih belum memiliki Bank Darah tersendiri, masih bekerjasama dengan PMI Kab Malang dan Kota Malang, sehingga untuk kebutuhan labu darah memerlukan waktu untuk pemesanan dan pengambilan.
- 10 Tersedia pelayanan penunjang lain yang berperan dalam PONEK seperti :
 - a. Laboratorium dan Radiologi selama 24 jam,
 - b. recovery room 24 jam,
 - c. obat dan alat penunjang yang selalu siap tersedia.

5.2 Tata Laksana Pelayanan Kehamilan

Menurut departemen Kesehatan RI (2018), petugas kesehatan melakukan pelayanan kehamilan sesuai dengan standart pelayanan antenatal, diantaranya :

- a. Melakukan anamnesis secara lengkap yaitu :
 - 1) Riwayat kehamilan sekarang
 - 2) Riwayat obstetri masa lalu
 - 3) Riwayat penyakit
 - 4) Riwayat sosial ekonomi
- b. Melakukan pemeriksaan
 - 1) Pemeriksaan Fisik umum
 - 2) Pemeriksaan luar (abdomen)



-
- 3) Pemeriksaan dalam bila diperlukan
 - 4) Pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik
- c. Melakukan assesment/diagnosa
 - d. Mengupayakan kehamilan yang sehat
 - 1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin
 - 2) Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan
 - 3) Ibu mengikuti kelas ibu
 - 4) Memberikan nutrisi yang adekuat
 - e. Melakukan deteksi dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil. Termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pebedahan serta melakukan penatalaksanaan awal serta rujukan bila diperlukan.
 - f. Memberikan pelayanan/ asuhan standart minimal termasuk 12 T yaitu :
 - 1) Timbang berat Badan
 - 2) Tekanan darah diukur
 - 3) Tetapkan status gizi (lila)
 - 4) Tinggi Fundus uteri diukur
 - 5) Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin
 - 6) Tes laboratorium
 - 7) Tablet tambah darah diberikan minimal 90 tablet selama kehamilan
 - 8) TT (tetanus Toksoid) Lengkap
 - 9) Tatalaksana kasus
 - 10) Temu wicara
 - 11) Tes skrining kesehatan jiwa
 - 12) Tata laksana dan skrining penyakit menular maupun tidak menular
 - g. Ibu hamil suami dan keluarga mengetahui tanda bahaya kehamilan dan mengetahui apa yang harus dilakukan
 - h. Persiapan persalinan yang aman dan bersih
 - 1) Selalu melakukan personal hygiene
 - 2) Pakaian dala diganti minmal 2x sehari
 - 3) Merencanakan ertolongan persalinan ke sarana kesehatan
 - i. Perencanaan antisipatif dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi
 - j. Pelayanan antenatal dapat dilakukan penanganan pasien dengan
 - 1) Pelayanan pasien dengan abortus
 - 2) Penanganan pasien dengan kehamilan ektopik (KE)
 - 3) Penanganan pasien dengan kehamilan ektopik terganggu (KET)
 - 4) Penanganan pasien dengan hipertensi
 - 5) Penanganan pasien dengan preeklamsia/eklamsia
 - 6) Penanganan pasien dengan plasenta previa
 - 7) Penanganan pasien dengan solusio lasenta
 - 8) Penanganan pasien dengan rupture uteri
 - 9) Penanganan pasien dengan kehamilan metabolic



5.3 Tata laksana Pelayanan Persalinan

Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 Minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin.

Pengkajian awal pada pelayanan persalinan adalah :

1. Melakukan anamnesis

Identitas asien, keuhan utama, riwayat persalinan, riwayat kebidanan, riwayat medik, riwayat sosial, riwayat kehamilan terdahulu, terakhir kali makan atau minum, lama istirahat/tidur, melakukan screening covid-19 (riwayat demam, batuk, pilek dan riwayat kontak dengan kasus emergin dalam 2 minggu terakhir).

2. Melakukan pemeriksaan fisik

Tanda-tanda vital, konjungtiva dan sklera, pemeriksaan abdomen, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, denyut jantung janin, pemeriksaan CTG sesuai indikasi, pemeriksaan dalam, pemeriksaan edema dan varises pada tangan dan kaki

1. Membuat diagnosis

Diambil kesimpulan dari hasil anamnesa pasien dan hasil pemeriksaan fisik, gravida berapa, pernah partus berapa kali dan pernah abortus berapa kali, parturien berapa minggu dan dalam kala berapa serta dalam fase apa, Misalnya G5P3003Ab1 UK 39 Minggu kala 1 fase laten

2. Membuat planing dan implementasi

a. Memberitahu hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

b. Pemantauan/observasi tanda vital, His DJJ dan kemajuan persalinan, yaitu

Tabel 5. 1 Pemantauan Observasi Persalinan

Kala I		TD	N	RR	S	His	DJJ	VT	Pencatatan
Laten	Normal	4 Jam	4 Jam	4 Jam	4 Jam	1 jam	1 jam	4 Jam	Lembar Observasi
	Induksi	4 Jam	4 Jam	4 Jam	4 Jam	30 Menit	30 Menit	4 Jam	Lembar Observasi
Aktif	Normal	4 Jam	30 Menit	4 Jam	2 Jam	30 Menit	30 Menit	4 Jam	Partograf
	Induksi	4 Jam	30 Menit	4 Jam	2 Jam	30 Menit	30 Menit	4 Jam	Partograf



- Kala I
 - 1) Berikan nutrisi dan idrasi pada ibu atau bisa dibantu oleh keluarga
 - 2) Berikan dukungan pada ibu dan keluarga
 - 3) Memastikan kembali partuset dan APD serta obat essensial siap pakai dan lengkap
 - 4) Memberikan informasi tentan Inisiasi Menyusui Dini dan Kontrasepsi
 - 5) Kolaborasi dengan dokter obgyn apabila tidak ada kemajuan persainan dan partograf telah berada dalam garis bertindak.
- Kala II adalah kala persalinan dimana pembukaan sudah lengkap yang dlakukan bidan adalah :

Tabel 6 tindakan kala II

Kemajuan Persalinan	Kondisi Ibu pasien	Kondisi Janin
• Usaha mengedan • Palpasi kontraksi uterus (kontrol tiap 10 menit) Frekuensi, lama dan kekuatanya	• Periksa nadi dan teanan darah tiap 30 menit • Respon keseluruhan pada kala II : a. Keadaan dehidrasi b. Perubahan sikap/prilaku c. Tingkat tenaga yang dimiliki	• Periksa FDJJ setiap 15 menit/ atau lebih sering dilakukan dengan semakin dekatnya kelahiran • Penurunan presentasi dan perubahan posisi • Warna cairan terentu



- 1) Pada kala II dipimpin mendedan apabila Kepala janin sudah tampak di vulva vagina dengan diameter 5-6 cm depan vulva, apabila belum tampak di vulva maka ibu boleh mendedan dalam posisi miring atau senyaman ibu.
 - 2) Memberikan dukungan terus menerus kepada ibu
 - 3) Menjaga personal hygiene
 - 4) Menyiapkan posisi ibu saat berair
 - 5) Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan meneran dengan posisi setengah duduk
 - 6) Menolong kelahiran dengan persina yang bersih dan aman
 - 7) Selama persalinan normal, intervensi hanya dilaksanakan jika benar-benar dibutuhkan. Prosedur ini hanya dibutuhkan jika ada infeksi atau penyulit
 - 8) Melakukan inisiasi menyusui dini selama 1 jam bila APGAR score bayi bagus.
- Kala III
 - 1) Cek uterus untuk menentukan apakah ada bayi kedua, jika ada tunggu sampai bayi lahir
 - 2) Memberikan injeksi oksitosin 10 iu IM dalam waktu 1 menit. Apabila plasenta belum lahir setelah 15 menit maka dapat diuangi oksitosin 10 iu IM kedua
 - 3) Menjepit dan menggunting tali pusat
 - 4) Menilai apakah bayi baru lahir dalam keadaan stabil, jika tidak lakukan resusitasi segera dan apabila bayi langsung mnenagis maka lakukan inisiasi menyusui dini sela 1 jam
 - 5) Melakukan penegangan tali pusat terkendali (PPT)
 - 6) Masase fundus uteri
 - Kala IV
 - 1) Periksa fundus, plasenta seaput ketuban, perinium, perdarahan, lochea, kandung kemih, kondisi ibu, kondisi bayi baru lahir
 - 2) Berikan nutrisi dan hidrasi
 - 3) Melanjutkan inisiasi menyusui dini (IMD) selam 1 jam
 - 4) Melakukan personal hygiene
 - 5) Dokumenasi dan dekontaminasi alat

5.4 Tata Laksana pelayanan Nifas

Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika kondisi kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 Minggu. Pada masa ini terjadi perubahan-perubahan fisiologis yaitu :

1. Perubahan fisik
2. Involusi uterus dan pengeluaran lochea
3. Laktasi/pengeluaran air susu ibu
4. Perubahan sistem tubuh lainnya
5. Perubahan psikis pemeriksaan pada ibu nifas
6. Pelayanan masa post natal dapat melakukan pelayanan pasien dengan :



- a. Masa nifas
- b. Demam pasca persalinan
- c. Perdarahan pasca persalinan
- d. Nyeri perut pasca persalinan
- e. Keluarga berencana

5.5 Tata Laksana Rawat Gabung

Adalah suatu kegiatan yang membiarkan ibu dan bayi bersama terus menerus selama di rumah sakit. Rawat Gaun merupakan pilihan terbaik untuk merawat bayi dan ibu yang sehat karena dapat meningkatkan pemberian ASI, mengurangi resiko infeksi, meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi, dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Rawat gabung dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Rawat gabung penuh
Sistem perawatan ibu dan bayi bersama secara terus menerus selama 24 jam
2. Rawat Gabung parsial
Suatu sistem perawatan ibu dan bayi hanya beberapa jam seharinya.

5.6 Tata Laksana Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

1. Definisi
Inisiasi Menyusui Dini(IMD) adalah permulaan kegiatan menyusui dalam satu jam pertama setelah bayi lahir. Inisiasi dini juga bisa diartikan sebagai cara bayi menyusui satu jam pertama setelah lahir dengan usaha sendiri dengan kata lain menyusui bukan disusui. Cara bayi melakukan inisiasi menyusui dini ini dinamakan The Breast Crawl atau merangkak mencari payudara (Maryunani, 2012).

Inisiasi Menyusui Dini adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusui segera dalam satu jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibunya, bayi dibiarkan setidaknya selama satu jam di dada ibu, sampai bayi menyusui sendiri (Depkes, 2008)

2. Prinsip inisiasi menyusui dini (IMD)
Inisiasi Menyusui Dini adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusui segera dalam satu jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibu bayi dibiarkan setidaknya selama satu jam di dada ibu, sampai dia menyusui sendiri. (Depkes, 2014)

Prinsip dasar IMD adalah tanpa harus dibersihkan dulu, bayi diletakkan di dada ibunya dengan posisi tengkurap dimana telinga dan tangan bayi berada dalam satu garis sehingga terjadi kontak kulit dan secara alami bayi mencari payudara ibu dan mulai menyusui. (Rosita, 2008) Kesimpulan dari pendapat di atas, prinsip IMD adalah cukup mengeringkan tubuh bayi yang baru lahir dengan kain atau handuk tanpa harus memandikan, tidak membungkus (bedong) kemudian meletakkannya ke dada ibu dalam keadaan tengkurap sehingga ada kontak kulit dengan ibu, selanjutnya beri kesempatan bayi untuk menyusui sendiri pada ibu pada satu jam pertama kelahiran



3. Manfaat Inisiasi Menyusui Dini

Menurut Roesli (2008), menyampaikan bahwa IMD bermanfaat bagi ibu dan bayi baik secara fisiologis maupun psikologis, yaitu sebagai berikut:

- a. Ibu
Sentuhan dan hisapan payudara ibu mendorong keluarnya oksitoksin. Oksitoksin menyebabkan kontraksi pada uterus sehingga membantu keluarnya plasenta dan mencegah perdarahan. Oksitoksin juga menstimulasi hormon-hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman, sehingga ASI keluar dengan lancar.
- b. Bayi Bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Bayi memperoleh kolostrom yang mengandung antibodi dan merupakan imunisasi pertama. Di samping itu, kolostrom juga mengandung faktor pertumbuhan yang membantu usus bayi berfungsi secara efektif, sehingga mikroorganisme dan penyebab alergi lain lebih sulit masuk ke dalam tubuh bayi.
- c. Manfaat secara Psikologis :
 - 1) Adanya Ikatan Emosi (Emotional Bonding) :
 - a. Hubungan ibu-bayi lebih erat dan penuh kasih sayang.
 - b. Ibu merasa lebih bahagia.
 - c. Bayi lebih jarang menangis.
 - d. Ibu berperilaku lebih peka (affectionately).
 - e. Lebih jarang menyiksa bayi (child abused).
 - 2) Perkembangan : anak menunjukkan uji kepintaran yang lebih baik di kemudian hari

4. Tata Laksana IMD

Menurut Depkes (2023), dalam buku pedoman pelaksanaan program rumah sakit sayang ibu dan anak, tatalaksana IMD yaitu:

- a. Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat persalinan.
- b. Disarankan untuk tidak atau mengurangi penggunaan obat kimiawi saat persalinan. Dapat diganti dengan cara non kimiawi, misalnya pijat, aroma therapy atau gerakan.
- c. Biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan, misalnya melahirkan normal, didalam air atau dengan jangkrik.
- d. Keringkan bayi secepatnya, kecuali kedua tangannya. Pertahankan lemak putih alami (vernix) yang melindungi kulit baru bayi.
- e. Bayi di tengkurapkan didada atau perut ibu. Biarkan kulit bayi melekat dengan kulit ibu. Posisi kontak kulit dengan kulit ini dipertahankan minimum satu jam atau setelah menyusui awal selesai. Keduanya diselimuti, jika perlu gunakan topi bayi.
- f. Biarkan bayi mencari puting susu ibu. Ibu dapat merangsang bayi dengan sentuhan lembut, tetapi tidak memaksakan bayi ke puting susu.
- g. Ayah didukung agar membantu ibu untuk mengenali tanda-tanda atau perilaku bayi sebelum menyusui.
- h. Dianjurkan untuk memberikan kesempatan kontak kulit pada ibu yang melahirkan dengan tindakan, misalnya operasi sectio caesarea.
- i. Bayi dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur dan dicap setelah satu jam



atau menyusui awal selesai. Prosedur yang invasif misalnya suntikan vitamin K dan tetesan mata bayi dapat ditunda.

- j. Rawat gabung-ibu dan bayi dirawat satu kamar selama 24 jam, bayi tetap tidak dipisahkan dan bayi selalu dalam jangkauan ibu. Pemberian minuman prelaktal (cairan yang diberikan sebelum ASI keluar) dihindarkan.

Depkes (2023) juga menjelaskan tatalaksana IMD pada persalinan sectio caesarea, yaitu :

- a. Tenaga dan pelayanan kesehatan yang suportif.
 - b. Jika mungkin, diusahakan suhu ruangan 20°-25°
 - c. Disediakan selimut untuk menutupi punggung bayi untuk mengurangi hilangnya panas dari kepala bayi.
 - d. Usahakan pembiusan ibu bukan pembiusan umum tetapi epidural.
 - e. Tatalaksana selanjutnya sama dengan tatalaksana umum diatas.
 - f. Jika inisiasi dini belum terjadi dikamar bersalin, kamar operasi, atau bayi harus dipindah sebelum satu jam maka bayi tetap diletakan didada ibu ketika dipindahkan ke kamar perawatan atau pemulihan. Menyusui dini dilanjutkan di kamar perawatan ibu atau kamar pulih.
5. Faktor-faktor yang menghambat IMD

Maryunani (2023) menjelaskan, ada faktor-faktor yang dapat menghambat IMD baik pada persalinan normal maupun pada persalinan sectio caesarea.

- a. Faktor-faktor yang menghambat IMD pada persalinan normal, yaitu :
 - 1) Pada persalinan normal, diharapkan agar setiap ibu dapat mencapai keberhasilan, mampu melaksanakan program IMD tidak lebih dari satu jam.
 - 2) Namun pada kenyataannya, ada beberapa ibu yang mengeluhkan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan IMD.
 - 3) Beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan program IMD pada pasien dengan persalinan normal tersebut, antara lain :
 - a) Kondisi ibu yang masih lemah (bagi ibu post-partum normal, dalam kondisi kelemahan ini, ibu tidak mampu untuk melakukan program IMD).
 - b) Ibu lebih cenderung suka untuk beristirahat saja dari pada harus kesulitan membantu membimbing anaknya untuk berhasil melakukan program IMD.



- b. Faktor-faktor yang menghambat IMD pada persalinan sectio caesarea, yaitu :

- 1) Rooming-in (Rawat Gabung).
- 2) Kondisi sayatan di perut ibu. Pada pasien caesar, dimana terdapat sayatan di perut, ibu cenderung masih mengeluhkan sakit pada daerah sayatan dan jahitan di perut, sehingga ibu memilih untuk istirahat, dahulu, dan memulihkan kondisinya yang lemas sebelum memberikan IMD pada bayinya. Oleh karena itu, maka pada pasien dengan persalinan caesar, ibu baru bisa berhasil memberikan ASI pertamanya kepada bayi setelah lebih dari satu jam pasca melahirkan.
- 3) Kondisi kelemahan akibat pengaruh anestesi yang diberikan sebelumnya

5.7 Tata Laksana Pelayanan Metode Kangguru (PMK) pada Bayi Baru Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR)

1. Pengertian

Perawatan metode kangguru merupakan alternatif metode perawatan bayi barulahir. Metode ini adalah salah satu teknik yang tepat dan sederhana, serta murah dan sangat dianjurkan untuk perawatan pada bayi BBLR. Metode ini tidak hanya menggantikan inkubator, tetapi juga dapat memberikan manfaat lebih yang tidak didapat dari pemberian inkubator. Pemberian metode kangguru ini dirasa sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan bayi yang sangat mendasar seperti kehangatan, air susu ibu, perlindungan dari infeksi, stimulasi, keselamatan dan kasih sayang (Depkes, 2024).

2. Jenis Perawatan Metode Kangguru Pemberian metode kangguru terdapat dua jenis, perawatan metode kangguru intermitten dan kontinyu:

a. Perawatan Metode Kangguru Intermitten

Metode ini biasanya dilakukan pada fasilitas unit perawatan khusus dan intensif. Metode ini tidak diberikan secara terus menerus sepanjang waktu, hanya diberikan ketika ibu mengunjungi bayi yang masih berada dalam inkubator dengan durasi minimal satu jam secara terus menerus dalam satu hari. Metode ini dapat dimulai pada bayi yang sakit, yang berada dalam proses penyembuhan tetapi masih memerlukan pengobatan medis (seperti infus, tambahan oksigen dengan konsentrasi rendah) (Depkes, 2024)

b. Perawatan Metode Kangguru Kontinyu

Metode kontinyu ini bisa dilakukan di unit rawat gabung atau ruangan yang diperuntukan untuk perawatan kangguru ataupun dilakukan di rumah. Pada metode kontinyu ini dapat dilakukan sepanjang waktu. Perawatan kontinyu dapat diterapkan apabila kondisi bayi dalam kondisi stabil yakni bayi dapat bernafas secara alami atau spontan tanpa oksigen bantuan (Depkes, 2024).

3. Lama dan jangka waktu penerapan PMK

a. Secara bertahap lama waktu penerapan metode kangguru ditingkatkan dari:

- 1) Mulai dari perawatan belum menggunakan perawatan metode kangguru
- 2) Dilanjutkan dengan pemberian perawatan metode kangguru intermitten



- 3) Kemudian diikuti dengan perawatan metode kangguru kontinyu (Depkes, 2024)
- b. Pelaksanaan metode kangguru yang singkat kurang dari 60 menit dapat membuat bayi stress. Strategi yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut antara lain:
 - 1) Jika bayi masih berada di fasilitas pelayanan kesehatan, maka lebih baik bayi diletakkan di inkubator.
 - 2) Apabila bayi telah dilakukan pemulangan, anggota keluarga lain dapat menggantikan ibu dalam melaksanakan perawatan metode kangguru (Depkes, 2024)
 - 3) Pemberian metode kangguru dapat dihentikan, apabila :
 - a) Berat badan bayi minimal >2500 gram
 - b) Bayi mampu menetek dengan kuat seperti bayi besar dan sehat
 - c) Suhu tubuh bayi stabil 37°C (Depkes, 2024)
4. Tujuan Perawatan Metode Kangguru
Tujuan dari pemberian metode kangaroo mother care adalah untuk menjaga agar bayi tetap hangat. Metode ini dapat dimulai segera setelah bayi lahir atau setelah bayi stabil. Metode ini dapat dilakukan di rumah sakit maupun di rumah. Pemberian metode ini dapat terus dilakukan meskipun bayi belum bisa menyusui (Depkes, 2024).
5. Pelaksanaan Perawatan Metode Kangguru
 - a. Pelaksanaan metode kangguru adalah skin to skin atau kulit dengan kulit antara bagian depan tubuh bayi dengan dada dan perut ibu dalam baju kangguru. adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: Semua pakaian bayi dilepas
 - b. Ibu atau keluarga yang akan menggendong diminta melepas BH atau baju dalam (hanya memakai baju/atau kaos yang longgar)
 - c. Gendong bayi, letakkan bayi didalam baju sehingga terjadi sentuhan kulit ibu dan kulit bayi tanpa perantara
 - d. Bebat/ikat pinggang ibu dibawah badan bayi sehingga badan badan bayi terhatan tidak turun (ikatan di luar baju)
 - e. Gendong bayi seperti biasa menggunakan kain, ikatan kain penggendong diluar baju ibu
 - f. Pakaikan topi penutup kepala bayi

5.8 Tata Laksana Bayi Baru Lahir

Tujuan utama perawatan bayi segera setelah lahir adalah :

1. Membersihkan jalan nafas
2. Memotong jalan nafas
3. Memertahankan suhu tubuh bayi
4. Identifikasi
5. Pencegahan infeksi
6. Pemantauan bayi baru lahir :
 - a. Kemampuan menghisap kuat atau lemah
 - b. Bayi tampak aktif atau lunglai
 - c. Bayi kemerahan atau biru
 - d. Bayi kecil untuk masa kehamilan atau bayi kurang bulan



-
- e. Gangguan pernafasan
 - f. Hipotermia
 - g. Infeksi
 - h. Cacat bawaan dan trauma lahir
7. Pemeriksaan pada bayi baru lahir :
- a. Pernafasan (normal, mendengkur, hidung mengembung, penarikan kembali tersengal sengal atau tidak)
 - b. Berat badan dan panjang badan
 - c. Suhu badan
 - d. Refleks (menghisap, rooting, menggenggam)
 - e. Warna kulit (kemerahan, biru, pucat, kuning)
 - f. Keadaan mata (jernih, berair, kuning)
 - g. Keadaan talipusat (kering, mengeluarkan darah atau tidak)
 - h. Kelainan (bibir/langit-langit sumbing, anus tidak berlubang)
8. Pelayanan kesehatan neonatal dapat melakukan pelayanan pasien dengan :
- a. Hiperbilirubin
 - b. Asfixia
 - c. Trauma kelahiran
 - d. Hipoglikemi
 - e. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit
 - f. Gangguan pernafasan
 - g. Pemberian cairan parenteral
 - h. Aspirasi mekonial
 - i. Inisiasi dini ASI (Breast Feeding)
 - j. Kanggoro Mother Cara (PMK)

5.9 Tata Laksana Pelayanan High Care Unit

- 1. Penanganan pada pasien eklamsia
- 2. Penanganan pada pasien perdarahan ante partum
- 3. Penanganan pada pasien perdarahan post partum
- 4. Penanganan pada pasien pre eklamsia berat
- 5. Penanganan pada pasien Syok
- 6. Penanganan pada pasien emergency



5.10 Tata laksana pelayanan kesehatan neonatal

1. Hiperbilirubinemia
2. Asfiksia
3. Trauma kelahiran
4. Hipoglikemi
5. Kejang/ sepsis neonatal
6. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit
7. Gangguan ernafasan
8. Gangguan perdarahan
9. Syok
10. Aspirasi mekonium
11. Inisiasi dini ASI (Breast Feeding)
12. Kanggoroo Mother Care (PMK)
13. Resusitasi neonatus
14. Pemberian minum pada bayi resiko tinggi
15. Ibu dengan kasus emergency

5.11 Tata laksana pelayanan Ginekologi

1. Penanganan pasien dengan kehamilan ektopik
2. Penanganan pasien dengan kista ovarium
3. Penanganan pasien dengan Infeksi saluran genitalia
4. Penanganan pasien dengan endometriosis
5. Penanganan pasien dengan perdarahan uterus disfungsi
6. Penanganan pasien dengan perdarahan menoragi

5.12 Tata Laksana pelayanan kamar operasi

1. Sectio caesaria
2. Perbaikan robekan dinding uterus
3. Reposisi inversio uteri
4. Histerektomy
5. Anestesi umum dan spinal untuk SC



5.13 Sistem Rujukan.

1. Pengertian Rujukan

Sistem Rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Kegiatan rujukan mencakup:

a. Rujukan Pasien

Rujukan pasien internal adalah rujukan antar spesialis dalam satu rumah sakit. Rujukan eksternal adalah rujukan antar spesialis keluar rumah sakit dengan mengikuti sistem rujukan yang ada

b. Rujukan Manajemen

Dapat berupa permintaan kepada unit yang lebih mampu atau bantuan kepada unit yang kurang mampu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang tidak dapat diatasi sendiri.

2. Sistem pelayanan rujukan maternal dan perinatal di rumah sakit Prima Husada

Bila pasien maternal dan perinatal tidak dapat ditangani sendiri segera rujuk ke sarana kesehatan yang lebih lengkap fasilitas dan tenaga kesehatannya. Harus ada koordinasi, mudah sehingga tidak merugikan pasien. Mudah, cepat dan tepat adalah yang utama.

Rujukan internal rumah sakit berpedoman kepada prosedur rujukan di dalam rumah sakit dan mekanisme kerja di bagian /instalasi Anak, Obstetri, dan Ginekologi. Rujukan eksternal mengikuti mekanisme rujukan sesuai jenjang pelayanan.

Melakukan Persiapan Rujukan Pasien ke jenjang pelayanan yang lebih tinggi yaitu

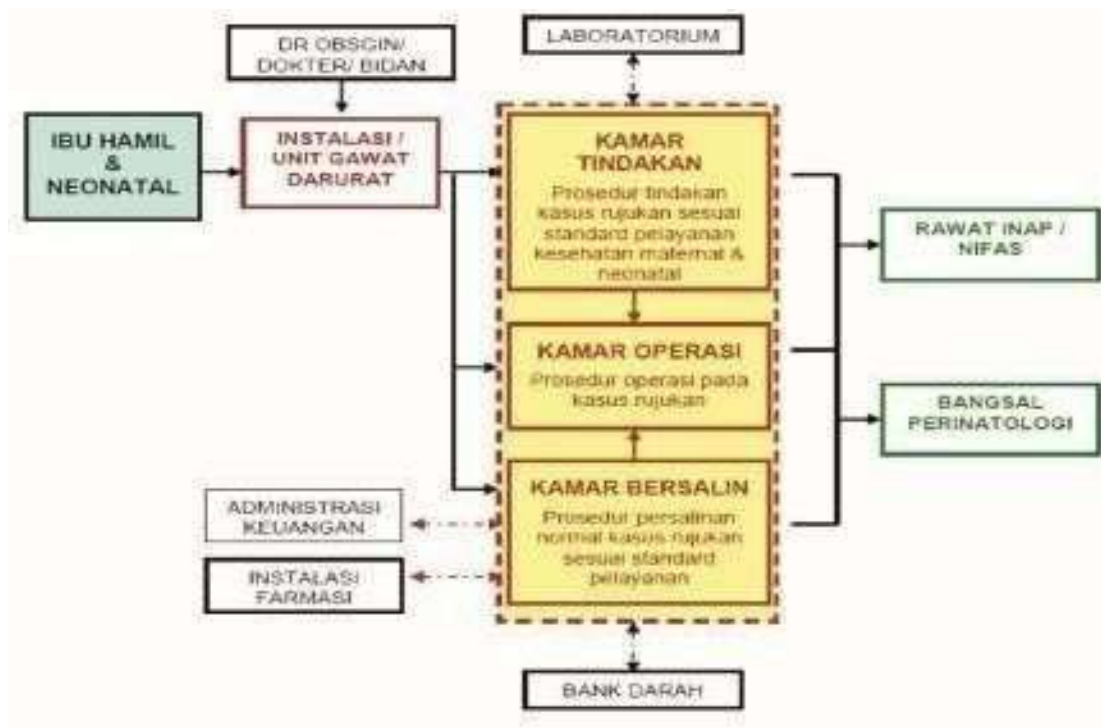
- Menyiapkan petugas yang terlatih untuk mendampingi pasien
- Memberi penjelasan kepada pihak keluarga alasan pasien di rujuk ke rumah sakit lain.
- Memberi penjelasan kepada pasien dan keluarganya
- bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayinya.
- Pada saat merujuk pasien harus disertakan surat rujukan dan resume medik pasien meliputi: riwayat penyakit, penilaian kondisi pasien yang dibuat saat kasus diterima perujuk, tindakan atau pengobatan yang telah diberikan dan keterangan lain yang perlu atau ditemukan sehubungan dengan kondisi pasien.
- Proses pelaksanaan rujukan harus mendapat persetujuan dari dokter dan keluarga

Rumah Sakit sebagai penerima rujukan yaitu :

- Memberi penjelasan kepada pasien dan keluarganya
- Bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayinya.
- Persiapan pihak keluarga untuk memberikan darah jika dibutuhkan
- Pasien/keluarga diberi penjelasan mengenai tindakan/perawatan yang akan dilaksanakan.



5.14 Alur masuk pasien PONEK



BAB VI

PENERAPAN PROGRAM RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI

6.1 PENGERTIAN

Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi adalah Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, umum dan khusus yang telah melaksanakan 10 Langkah menuju perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.

6.2 TUJUAN

1. Umum :

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara terpadu dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

2. Khusus :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk kepedulian terhadap ibu dan bayi.
- c. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetrik dan neonatus termasuk pelayanan kegawat daruratan (PONEK 24 Jam)
- d. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- e. Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan pembina teknis dalam pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif
- f. Meningkatkan fungsi Rumah Sakit dalam Perawatan Metode Kangguru (PMK) pada BBLR.
- g. Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RSSIB

6.3 SASARAN

Ibu nifas dan bayi baru lahir di rumah sakit prima husada

6.4 STRATEGI PELAKSANAAN

Melaksanakan Perlindungan Ibu dan Bayi secara terpadu dan paripurna melalui 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :

1. Ada kebijakan tertulis tentang manajemen yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk pemberian ASI eksklusif dan Perawatan Metode Kangguru (PMK) untuk bayi Berat Badan Lahir Rendah.
2. Menyelenggarakan pelayanan antenatal termasuk konseling kesehatan maternal dan neonatal
3. Menyelenggarakan persalinan bersih dan aman serta penanganan pada bayi baru lahir dengan Inisiasi menyusui dini dan kontak kulit ibu-bayi.
4. Menyelenggarakan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
5. Menyelenggarakan pelayanan adekuat untuk nifas, rawat gabung termasuk membantu ibu menyusui yang benar, dan pelayanan neonatus sakit
6. Menyelenggarakan pelayanan rujukan dua arah dan membina jejaring rujukan pelayanan ibu dan bayi dengan sarana kesehatan lain.



7. Menyelenggarakan pelayanan imunisasi bayi dan tumbuh kembang
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi lainnya
8. Menyelenggarakan Audit Maternal dan Perinatal Rumah Sakit secara periodik dan tindak lanjut
9. Memberdayakan Kelompok pendukung ASI dalam menindaklanjuti pemberian ASI eksklusif dan PMK



BAB VII

LOGISTIK

7.1 SARANA DAN PRASARANA

Tabel 7. 1 Sarana dan Prasarana (Logistik)

No	Nama Unit	Nama Alat	Jumah
1	Poliklinik	1. USG 2. Lampu sorot 3. Kulkas 4. Stetoskop 5. Tensimeter 6. Metelin 7. Patella hammer 8. Timbangan 9. Senter 10. Timbangan bayi manual dan digital 11. Pengukur tinggi badan 12. Sudip lidah 13. IUD Set 14. Rawat luka set 15. Implan set	2 Set 1 pcs 1pcs 2 pcs 2pcs 2pcs 1pcs 2pcs 2pcs 1/1 set 1set 1pcs 6 set 6 set 2set
2	IGD PONEK	1. Partus set 2. Curet Set 3. Resusitasi ibu dan bayi 4. Lampu sorot 5. Infus pump 6. Syringe pump 7. Infant warmer 8. Suction bayi 9. Dopler 10. NST 11. Metline 12. Timbangan dewasa dan bayi 13. Dipstik 14. Kulkas	2set 1set 1/1 set 1pcs 1set 1set 1set 1set 1set 1set 1set 1/1pcs 1set 1set



3	Kamar Bersalin	1. Vakum 2. Resusitasi bayi 3. Resusitasi ibu 4. Partus Set 5. Curretage set 6. IUD set 7. Heacting set 8. Lampu sorot 9. Senter	1set 1set 1set 7set 4set 2set 7set 2pcs 1pcs
		10. Doppler / Funandoskop 11. Metelin 12. Timbangan dewasa dan bayi 13. Dipstik 14. Tensi meter 15. Termometer 16. NST 17. Suction 18. Usg transport 19. Infant warmer 20. Showcase	2set 2set 1/1 pcs 1set 1set 1set 1set 1set 1set 1set 1set 1set
4	Ruang Nifas	1. Tensi meter 2. Termometer 3. Box bayi 4. Cuvis	1set 1set 15box 4pcs
5	Ruang Neonatus	1. Incubator 2. CPAP mesin 3. Incubator transport 4. Infus pump 5. Syringe Pump 6. Foto terapy 7. Resusitasi bayi 8. Saturasi bayi 9. Thermometer 10. Kulkas 11. Baby table 12. Infant warmer	4set 5set 1set 6set 5set 2set 1set 3set 2set 1set 1set 1set
6	Ruang Operasi	1 curret suction 2 SC 3 laparatomy	2set 6set 3set



7	Ruang Pojok Laktasi	1 Sofa 2 Wastafel 3 Baby table	1set 1set 1set
---	---------------------	--------------------------------------	----------------------

BAB VIII KESELAMATAN PASIEN

8.1 Pengertian

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi penilaian resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

Keselamatan pasien di ruang rawat inap merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada pasien, mengingat perawatan pada pasien rawat inap membutuhkan perhatian yang lebih dan membutuhkan penanganan jangka panjang yang perlu keseriusan dari tenaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kesalahan penanganan dalam praktiknya. Kejadian yang mengacu pada keselamatan pasien diantaranya pasien terjatuh dari tempat tidur, pasien diberi obat salah, tidak ada obat/alat emergensi, tidak ada oksigen, tidak ada alat penyedot lendir, tidak tersedia alat pemadam kebakaran, dan pemakaian obat.

8.2 Tujuan

- 1) Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit.
- 2) Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat.
- 3) Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di RS.
- 4) Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan.

8.3 Standar Keselamatan Pasien

- 1) Mengidentifikasi pasien dengan benar
- 2) Meningkatkan komunikasi yang efektif
- 3) Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai
- 4) Memastikan sisi yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ Tindakan invasif
- 5) Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
- 6) Mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh

8.4 Kejadian Yang Dapat Muncul Dalam Pelayanan

Kesalahan dalam sasaran keselamatan pasien bisa menyebabkan kefatalan dalam pelayanan, yaitu bisa menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Contoh dalam hal ini adalah kesalahan dalam mengidentifikasi pada saat sebelum melakukan Tindakan, identifikasi tidak dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO).



8.5 Tata Laksana

1. Mengidentifikasi pasien dengan benar
 - a. Setiap pasien yang masuk rawat inap dipasangkan gelang identitas pasien.
 - b. Gelang identitas untuk pasien laki-laki berwarna biru muda dan gelang identitas untuk perempuan berwarna merah muda. Bila pasien ada resiko jatuh diberi stiker warna kuning dan bila pasien ada alergi diberi stiker warna merah di gelang identitas pasien
 - c. Ada dua identitas yang digunakan yaitu nama dan tanggal lahir yang disesuaikan dengan tanda pengenal resmi.
 - d. Identifikasi pasien dilakukan pada saat sebelum :
 1. Melakukan tindakan/ intervensi/ terapi (misalnya pemberian obat, pemberian darah atau produk darah, melakukan terapi radiasi).
 2. Melakukan tindakan (misalnya memasang jalur intravena atau hemodialisa)
 3. Sebelum tindakan diagnostic apa pun (misalnya mengambil darah dan specimen lain untuk pemeriksaan laboratorium penunjang, atau sebelum melakukan keterisasi jantung ataupun Tindakan radiologi diagnostic)
 4. Menyajikan makanan pasien
 5. Staf unit pelayanan
2. Meningkatkan komunikasi yang efektif
 - a. Metode, formulir dan alat bantu ditetapkan sesuai dengan jenis komunikasi agar dapat dilakukan secara konsisten dan lengkap
 - b. Metode komunikasi saat menerima intruksi melalui telepon adalah : menulis/ menginput ke computer – membackan – konfirmasi kembali (*writedown, read back, confirmation*)
 - c. Saat melaporkan metode yang digunakan adalah *Situation – Background – Assessment – Recommendation* (SBAR)
 - d. Metode komunikasi saat melaporkan nilai kritis pemeriksaan diagnostic melalui telpon juga dengan menggunakan menulis/ menginput ke computer – membackan – konfirmasi kembali (*writedown, read back, confirmation*)
 - e. Metode komunikasi saat serah terima antar ruangan dan atau di salam ruangan menggunakan formulir khusus
3. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai
 - a. Obat risiko tinggi yaitu obat dengan zat kimia yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi kesalahan dalam penggunaannya
 - b. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (nama obat rupa dan ucapan mirip/ NORUM, atau LASA(look alike sound alike))
 - c. Elektrolit konsentrat yang melebihi 50%, contoh : KCL 3%, NS 3%.
 - d. Ada protocol dalam pemberian terapi dalam menanggulangi hypokalemia, hyponatremia, dan hipofastemia yang sudah tertera dalam PPK (panduan praktek klinis)
4. Memastikan sisi yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ Tindakan invasive



- a. Tindakan operasi dan invasive meliputi semua tindakan yang melibatkan insisi atau pungsi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, operasi terbuka, aspirasi perkutan, injeksi obat tertentu, biopsy, tindakan intervensi atau diagnostic vaskuler dan kardiak perkutan, laparaskopi, ekstraksi gigi, ESWL, dan endoskopi. Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien
 - b. Penandaan lokasi tindakan operasi/ invasive dilakukan oleh PPA yang akan melakukan tindakan tersebut
 - c. PPA tersebut akan melakukan seluruh prosedur operasi/ invasive dan tetap berada dengan pasien selama tindakan berlangsung
 - d. Pada tindakan operasi, dokter operator/ dokter penanggung jawab pasien (DPJP) bedah akan melakukan tindakan penandaan lokasi
 - e. Tindakan invasive non-operasi, penandaan dilakukan oleh dokter yang akan melakukan tindakan
 - f. Penandaan dapat dilakukan di area luar kamar operasi
 - g. Penandaan sisi operasi dilakukan dengan melibatkan pasien serta dengan tanda yang tidak memiliki arti ganda serta segera dapat dikenali yaitu dengan tanda lingkaran dan panah pada area yang akan dilakukan tindakan
 - h. Tanda harus terlihat sampai pasien disiapkan
 - i. Penandaan sisi operasi hanya ditandai pada semua kasus yang memiliki dua sisi kiri dan kanan (lateralisasi), struktur multiple (jari tangan, jari kaki, lesi) atau multiple level (tulang belakang)
5. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
- a. Kebersihan tangan merupakan hal yang paling penting untuk mencegah penyebaran infeksi. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun harus segera dilakukan terutama saat tangan terlihat kotor atau terkontaminasi dengan bahan-bahan dari tubuh pasien. Penggunaan handrub dengan bahan alkohol dapat dilakukan secara rutin untuk memastikan tangan bebas dari kontaminasi atau hanya jika tangan tidak terlihat kotor, bukan menggantikan fungsi cuci tangan. Lakukan cuci tangan pada momen yang tepat, yaitu :
 - Sebelum kontak langsung dengan pasien.
 - Setelah kontak langsung dengan pasien.
 - Sebelum melakukan tindakan invasif pada pasien.
 - Setelah terkena cairan tubuh pasien.
 - Setelah bersentuhan dengan lingkungan sekitar pasien
6. langkah cuci tangan menggunakan handwash sebagai berikut :
- a. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih (kran, air yang dituangkan dari wadahnya mengalir tangan). Ambil 3-5cc sabun cair, ratakan dengan kedua telapak tangan.
 - b. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan jari-jari tangan kanan dan sebaliknya.
 - c. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari kedua telapak tangan.
 - d. Jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci.
 - e. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya.
 - f. Gosok arah berputar ujung-ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya.



- g. Bilas kedua tangan dengan air mengalir.
 - h. Keringkan dengan handuk sekali pakai atau tisu sampai benar-benar kering.
 - i. Tutup kran dengan handuk sekali pakai atau tisu
6. Mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh
- a. Pengkajian risiko jatuh pada semua pasien rawat inap baik dewasa maupun anak dilakukan sesuai regulasi Panduan Upaya Mengurangi Cedera Pasien Akibat Jatuh
 - b. Pengkajian ulang risiko jatuh pada pasien rawat inap dilakukan pada saat terjadi perubahan kondisi, atau memang sudah mempunyai risiko jatuh dari hasil pengkajian
 - c. Tindakan dan/ atau intervensi untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien rawat inap telah dilakukan dan didokumentasikan

BAB IX

KESELAMATAN KERJA

9.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit agar terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan SMK3 Rumah Sakit. SMK3 Rumah Sakit merupakan bagian dari sistem manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan.

9.2 Pengertian

Pengertian K3 Menurut Filosofi Mangkunegara, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

9.3 Tujuan

1. Terciptanya budaya keselamatan kerja di RS Prima Husada.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
3. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
4. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

9.4 Tata Laksana Keselamatan Kerja

Mengacu pada pengertian tersebut maka diharapkan setiap petugas rumah sakit dapat menerapkan sistem keselamatan kerja diantaranya:

5. Petugas mengerti SPO penggunaan APD sehingga dapat menggunakan APD sesuai prosedur.
6. Tersedianya APD yang memenuhi standar.
7. Tersedianya tempat pembuangan sampah yang dibedakan infeksius dan non infeksius serta terdapatnya tempat khusus untuk pembuangan jarum atau pun spuit bekas.
8. Aturan untuk tidak melakukan recuping jarum suntik setelah dipakai ke pasien.
9. Setiap pasien yang menular atau beresiko menular di rawat di ruang isolasi.
10. Setiap petugas medis maupun non medis menjalankan prinsip pencegahan infeksi,



yaitu

- a. Menganggap bahwa pasien maupun dirinya sendiri dapat menularkan infeksi
- a. Menggunakan alat pelindung (hazmat/ skort, sarung tangan, kacamata, sepatu boot/ alas kaki tertutup, celemek, masker, dll) terutama bila terdapat kontak dengan spesimen pasien yaitu: urin, darah, muntah, sekret, dll
- b. Melakukan tindakan yang aman bagi petugas maupun pasien, sesuai prosedur yang ada, misal : memasang kateter, menyuntik, menjahit luka, memasang infus, dll
- c. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik pada 5 momen.
2. Terdapat tempat sampah infeksius dan noninfeksius.
3. Mengelola alat dengan mengindahkan prinsip sterilitas yaitu:
 - a. Dekontaminasi dengan larutan klorin
 - b. Pencucian dengan sabun
 - c. Pengeringan
4. Menggunakan baju kerja yang bersih

9.5 Prinsip Keselamatan Kerja

Dalam prinsip kesehatan keselamatan kerja (K3) secara utuh di rumah sakit ada 3 komponen penting yang saling berhubungan, antara lain :

5. Kapasitas kerja, kemampuan seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik pada suatu tempat kerja dalam waktu tertentu.
6. Beban kerja, suatu kondisi yang membebani pekerja baik secara fisik maupun non fisik dalam menyelesaikan pekerjaannya, kondisi tersebut dapat diperberat oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung secara fisik atau non fisik.
7. Lingkungan kerja, kondisi lingkungan tempat kerja yang meliputi factor fisik, kimia, biologi, ergonomic dan psikososial yang mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.



BAB X

PENGENDALIAN MUTU

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu, pelayanan harus mempunyai suatu ukuran yang menjamin peningkatan mutu. Dalam kegiatan peningkatan mutu pelayanan PONEK perlu ada suatu program yang terencana dan berkesinambungan sebagai pedoman bagi pelayanan PONEK dalam mengevaluasi dan membuat rencana tindak lanjut sehingga tercapai peningkatan mutu pelayanan yang diharapkan. Indikator yang digunakan adalah dengan menggunakan Indikator PMKP

Mutu dari pelayanan PONEK meliputi :

Tabel 8. 1 Mutu Pelayanan PONEK

No	Indikator	Standar
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
2	Angka keterlambatan operasi SC Cito > 30 menit	0%
3	Angka keterlambatan penyediaan darah (> 60 menit)	0%
4	Angka kematian bayi	0%
5	Angka kematian ibu	0%
6	Kejadian tidak dilakukanya IMD (Inisiasi Menyusui Dini) pada bayi baru lahir	0
7	Kejadian perdarahan post partum	0
8	Kejadian partus lama	<10%
9	Kejadian eklamsi	0
10	Kejadian Pre eklamsi	0
11	Kejadian Infeksi Nifas	0

BAB IX

PENUTUP

Perawatan perinatal tidak dapat dipisahkan dengan riwayat kehamilan seorang ibu, sedangkan angka kematian maternal sendiri masih sangat tinggi yang banyak disebabkan karena perdarahan, infeksi dan hipertensi. Oleh sebab itu peningkatan kualitas dari pelayanan obstetric dari pusat rujukan adalah sangat penting. Rumah Sakit Prima Husada sebagai tempat pelayanan yang terkait secara khusus dalam pelayanan perinatal resiko tinggi berperan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dalam keikutsertaan untuk menurunkan angka kematian maternal neonatal.

Telah disusun suatu Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagai acuan untuk melaksanakan dan mengelola pelayanan kesehatan maternal neonatal di ruang lingkup Rumah Sakit Prima Husada.

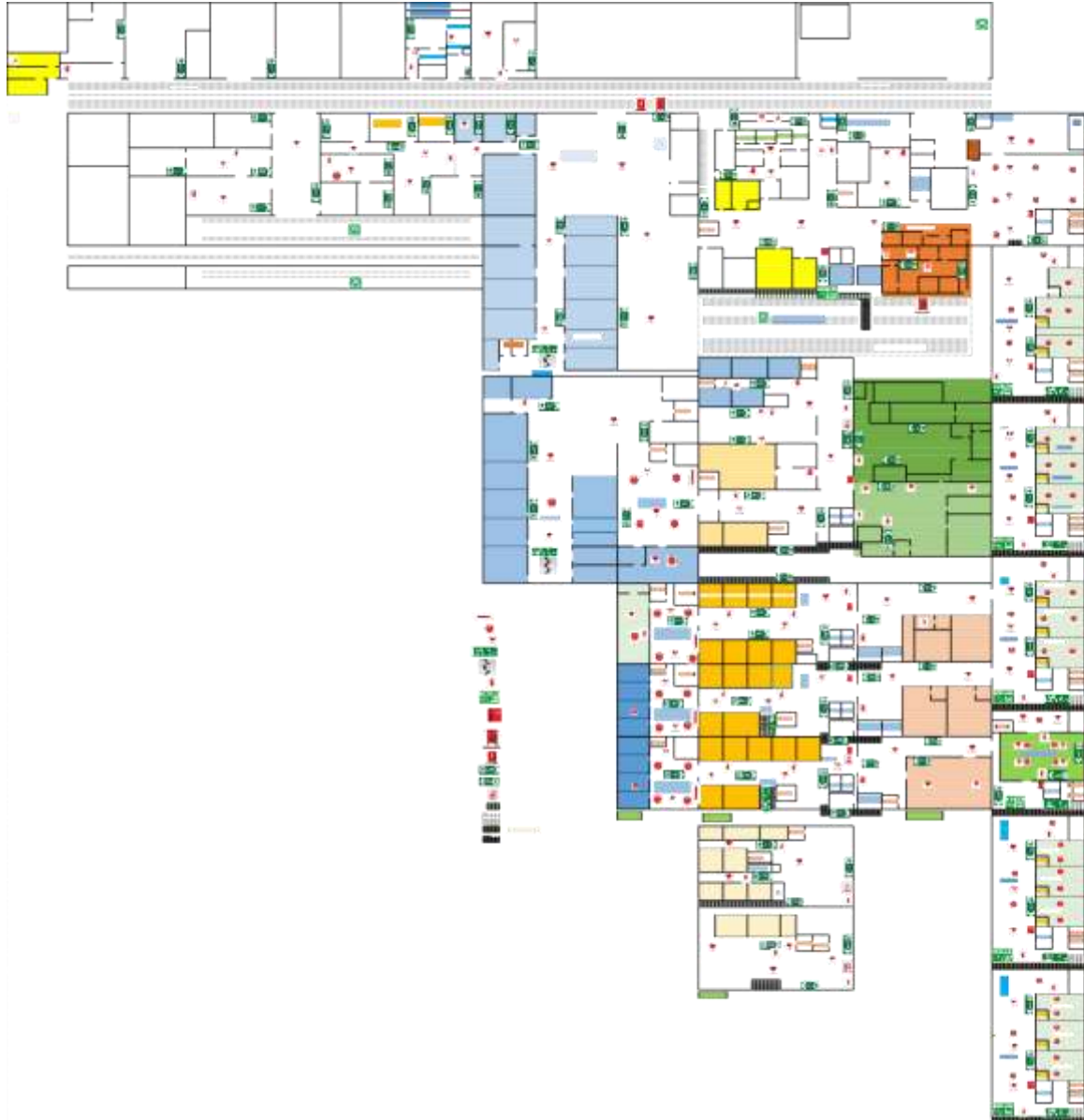
Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 11 September 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestanti, M.Kes

LAMPIRAN

Lampiran 1 Denah Rumah Sakit Prima





Lampiran 2 Denah PONEK RS Prima

